

Prática Baseada em Evidência – aulas 01, 02 e 03



Coorte Retrospectiva → viés de memoraria, pois não vão lembrar nem oq comeram ontem

Revisão sistemática → olhas os dados primários para verificar a qualidade dos estudos

Prontos de atenção:

Pacientes **heterogêneo ou homogêneos**, **financiamento** da pesquisa, **tipo de estudo**.

- **Viés de aferição ou medição** (equipamento utilizado, balança) → Erro na forma como os dados são coletados, como confiar apenas na memória do paciente para o que ele comeu nos últimos 10 anos
- **Viés de seleção** (casuística, população) → ocorre quando a amostra não representa a população real (ex: selecionar apenas pacientes saudáveis em um estudo sobre doença renal_.
- **Viés de autoridade** (segundo o Dr. X)
- **Viés de confundimento ou confusão** (QFA, R24H...)

Antes de elaborar nossa pergunta de investigação, temos que conhecer quais termos precisos usar na busca

Ex. Qual efeito da vitamina C na fibromialgia?

1. Acesso aos sites de busca
2. Digitar termos livres
3. Comparar a pesquisa com os descritores

A importância do termo adequado na pesquisa = descritores



DeCS/MeSH
Descritores em Ciências da Saúde

Estratégia PICO

Tabela 2.1 Componentes da pergunta de pesquisa seguindo o acrônimo PICO e sua composição conforme o cenário clínico.

Abreviação	Componente	Componentes do cenário clínico	Termos em inglês (MeSH)
P	População	Pessoas saudáveis	–
I	Intervenção	Dieta rica em potássio	Potassium; dietary potassium
C	Comparação	Dieta normal	–
O	Desfecho	Doenças cardiovasculares	Cardiovascular diseases

➔ Para caso clínico

1. O Ponto de Partida: Hipótese Nula (H0)

- O que é: É a afirmação de que "não há diferença".
- Na prova: Se o estudo testa um novo remédio, a H0 diz que o remédio novo e o placebo têm o mesmo efeito.
- O objetivo: Tentar encontrar evidências fortes o suficiente para "derrubar" (rejeitar) essa hipótese nula.

2. O Veredito Estatístico: Valor de P (P-value)

- **Definição:** A probabilidade de os resultados obtidos terem ocorrido por puro acaso, assumindo que a H0 é verdadeira.
- **Corte Clássico:** Geralmente 0,05 (5%).
 - **P < 0,05:** Rejeitamos a H0. O resultado é **estatisticamente significativo**.
 - Significa que é muito improvável (menos de 5% de chance) que a diferença encontrada tenha sido obra do acaso. Logo, o efeito observado provavelmente é real.
 - **P > ou igual a 0,05:** Não podemos rejeitar a H0. O resultado **não é significativo** (pode ter sido acaso).
- **⚠ Cuidado:** O artigo alerta que um P < 0,05 prova que existe uma diferença, mas não prova que essa diferença seja importante para o paciente.

3. A Precisão dos Dados: Intervalo de Confiança (IC)

- Enquanto o Valor de P foca no "sim ou não" (é real ou é acaso?), o Intervalo de Confiança nos mostra a **magnitude** e a **precisão** do efeito.
- **O que é:** Uma faixa que estima onde está o valor real da população com 95% de certeza.
- Como interpretar? Se um estudo diz que um remédio reduz a pressão em 10 mmHg com um IC de 95% entre [8 e 12], significa que temos 95% de certeza de que o valor real da redução na população está dentro dessa faixa.

- **Análise de Significância pelo IC:**
 - **Diferença de Médias:** Se o IC incluir o **ZERO** (ex: [-1,2 a 3,5]), o resultado **NÃO** é significativo.
 - **Razões (RR ou OR):** Se o IC incluir o **UM** (ex: [0,8 a 1,5]), o resultado **NÃO** é significativo.
- **Precisão:** Quanto mais **estrito (curto) for o intervalo** (ex: [9,5 a 10,5]),, mais **preciso** é o estudo (geralmente porque a amostra é grande).

4. Onde a maioria erra: Os Tipos de Erro

Erro	Nome	O que acontece?	Exemplo Clínico
Tipo I	Falso Positivo	Rejeitar H quando ela é verdadeira.	Dizer que o remédio funciona, mas ele não funciona.
Tipo II	Falso Negativo	Não rejeitar H0 quando ela é falsa.	Dizer que o remédio não funciona, mas ele funciona (estudo sem "poder").

Dica de Ouro: Para evitar o Erro Tipo II, aumentamos o tamanho da amostra (n).

5. Significância Estatística vs. Clínica

- **Estatística** (Matemática): O Valor de P diz se a diferença existe e não é acaso.
- **Clínica** (Prática): O médico avalia se essa diferença importa para o paciente.
- **Exemplo de Prova:** Um remédio que reduz a pressão em apenas 1 mmHg com $P = 0,001$
 - **É significativo estatisticamente?** Sim ($P < 0,05$).
 - **É significativo clinicamente?** Provavelmente não (redução muito pequena para mudar a conduta).

6. Ferramenta Prática: NNT (Número Necessário para Tratar)

- O que é: Quantos pacientes preciso tratar para evitar 1 desfecho negativo (ou obter 1 benefício).
- Ex: $NNT = 200 \rightarrow$ A cada 200 pacientes 1 terá efeito positivo com o tratamento.
- Interpretação: Quanto menor o NNT, melhor e mais eficaz é o tratamento.

Checklist Rápido para Questões:

1. **Olhou o P?** Se $< 0,05$, tem diferença.
2. **Olhou o IC?** Se não cruzou o zero/um, confirma o P. Se for estreito, é preciso.
3. Olhou a Magnitude? A melhora foi de quanto? 0,1% ou 30%? (Aqui você define se é clinicamente importante).